



GUIA PARA PACIENTES

Prótese de joelho: como se preparar e como é a recuperação

o que um cirurgião de joelho gostaria que você soubesse antes e depois da cirurgia

Quando a prótese faz sentido, o que esperar de verdade, como preparar o corpo e a casa e como é a recuperação, fase por fase.



**DR. ROBERTO
RODRIGUES**
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
CIRURGIA DO JOELHO

CRM-CE 10806 · RQE 12256 · TEOT 17765 · @robertorodriguesmd

Material educativo. Não substitui consulta médica.

Palavra-chave no Instagram: **PROTESE**

Para quem é:

Para quem tem artrose no joelho e está pensando na prótese, já tem a cirurgia marcada ou acabou de operar e quer entender o caminho.

Para quem NÃO é:

- Quem tem algum sinal de alerta da Página 3: primeiro o atendimento, depois o guia.
- Quem quer saber qual prótese, qual remédio ou qual dose: isso se decide na consulta.
- Quem já operou e recebeu um protocolo: **o protocolo da sua equipe vale mais do que este guia**. Se houver diferença, siga a equipe.

O que você vai precisar:

- Andador ou muletas, conforme orientação da equipe.
- Uma cadeira firme, com braços, sem rodinhas.
- A lista completa dos remédios que você usa.
- Uma caneta para o rastreador da Página 9.

Regra de ouro:

Depois da prótese, **dor e inchaço que melhoram de semana para semana** fazem parte do caminho.

Dor que piora, febre, ferida que muda ou falta de ar, não: leia a Página 3.

A maior parte da recuperação é dor e inchaço que vão cedendo. Mas algumas complicações dão sinais claros. **Leia esta página antes de qualquer outra.**

Ligue 192 (SAMU) ou vá ao pronto-socorro AGORA se:

- **Falta de ar de repente**, dor no peito que piora ao respirar, tosse com sangue ou desmaio. Pode ser **embolia pulmonar**: um coágulo que se soltou e foi para o pulmão.

Fale com a sua equipe HOJE se:

- **Dor, inchaço ou endurecimento na panturrilha** (a "batata da perna"), ou a perna inteira inchando cada vez mais. Pode ser **trombose** [11].
- **Febre** de 38 °C ou mais, ou calafrios.
- **Ferida com secreção**, que volta a sangrar, abre, ou fica **vermelha, quente e mais dolorida**. Infecção na prótese é incomum, cerca de 1,5% nos 2 primeiros anos num grande estudo americano com idosos [15], mas é uma das complicações mais sérias. Quanto antes avaliada, melhor (opinião clínica).
- **Dor que piora muito** de um dia para o outro, em vez de melhorar.
- **Queda**, principalmente se depois dela o joelho doer mais, inchar ou você não conseguir apoiar a perna.

Uma observação honesta: algum inchaço no joelho e na perna é esperado por semanas. Na dúvida, ligue (opinião clínica).

A indicação é a dor e a limitação, não só o raio-X

Em geral, a prótese é considerada quando três coisas aparecem juntas (opinião clínica, coerente com os estudos abaixo):

- **Artrose avançada** na radiografia, compatível com o exame físico.
- **Dor e limitação** que atrapalham andar, dormir ou trabalhar.
- **Tratamento sem cirurgia bem feito**, sem resultado suficiente: exercício, controle do peso e orientação.

O estudo que comparou os dois caminhos

Num estudo dinamarquês, 100 pessoas com artrose moderada a grave, todas com indicação de prótese, foram sorteadas para operar ou não. Os dois grupos fizeram 12 semanas de tratamento sem cirurgia [1]. Em 1 ano:

- Quem operou **melhorou cerca do dobro**: 32,5 contra 16,0 pontos, numa escala de 0 a 100.
- Quem operou teve **mais complicações graves**: 24 eventos contra 6.
- No grupo sem cirurgia, 26% acabaram operando.

Em 2 anos, **2 em cada 3** pessoas do grupo sem cirurgia ainda não tinham precisado operar [2].

A prótese funciona, mas tem risco. Tratar sem cirurgia primeiro não é perder tempo: para muita gente, é o caminho certo por um período.

A maioria fica satisfeita, mas não todos

Num estudo sobre satisfação, cerca de **1 em cada 5** pessoas operadas **não estava satisfeita** com a prótese. O fator que mais pesou foi a **expectativa não atendida** [3]. Por isso esta página existe.

Uma revisão de estudos encontrou **dor persistente** incômoda em 10% a 34% das pessoas depois da prótese de joelho. Nos estudos de melhor qualidade, em cerca de **1 em cada 5** [4].

O que costuma ficar (opinião clínica)

- Dificuldade ou desconforto para **ajoelhar**.
- **Dormência** numa área da pele ao lado da cicatriz.
- Algum **estalo** ou a sensação de um "joelho diferente".
- Um joelho que **não dobra como antes da artrose**.

Nada disso, sozinho, quer dizer que algo deu errado.

Quanto dura uma prótese

Somando registros nacionais de vários países, cerca de **82% das próteses totais de joelho ainda funcionavam 25 anos depois**. Nas próteses parciais (unicompartmentais), cerca de 70% [5].

Esses números vêm de próteses colocadas há décadas e **não são promessa** para um caso individual. Infecção, peso, nível de atividade e outros fatores pesam.

Parar de fumar

Num estudo com 120 pessoas que iam colocar prótese de quadril ou de joelho, quem recebeu ajuda para parar de fumar **6 a 8 semanas antes** teve **18% de complicações**, contra **52%** no grupo que não recebeu. Os problemas na ferida caíram de 31% para 5% [7].

Controlar o diabetes

Hemoglobina glicada alta (o exame que mostra a média do açúcar no sangue) está associada a **mais infecção** na prótese [8]. O valor exato a partir do qual se deve adiar a cirurgia ainda é discutido [9]. A sua meta é definida na consulta.

Exercício antes ("pré-habilitação")

Fortalecer a perna antes melhora a função **antes** da cirurgia, com evidência de certeza moderada, e pode ajudar nas **primeiras semanas** depois. O ganho a longo prazo é incerto [10]. Vale fazer; não é milagre.

Preparar a casa (opinião clínica)

- Tirar tapetes soltos e fios do caminho.
- Luz noturna entre o quarto e o banheiro.
- Barra de apoio e banco no box.
- Cadeira firme, com braços.
- Objetos do dia a dia ao alcance, sem subir em banco.

Remédios: leve a lista completa à consulta antes da cirurgia. Ajustar ou suspender algum é decisão da equipe, **nunca por conta própria**.

Prazos aproximados, que variam muito de pessoa para pessoa (opinião clínica, apoiada nos dados de [6]).

Primeiras 2 semanas

Ficar em pé e andar com andador começa cedo, conforme a liberação da equipe. Dor e inchaço são esperados. Prioridades: **esticar bem o joelho**, começar a dobrá-lo, andar dentro de casa e cuidar da ferida como orientado.

De 2 a 6 semanas

Fisioterapia, caminhadas mais longas e redução gradual do apoio. Cansaço e sono ruim são comuns nessa fase (opinião clínica). Dirigir e voltar ao trabalho: combine com a equipe.

Até 3 meses

Numa revisão de muitos estudos, a dor média caiu de 64 para 24, numa escala de 0 a 100, e a função subiu de 47 para 73 [6]. **A maior parte da melhora acontece aqui.**

Até 1 ano

A melhora continua, mais devagar: dor média de 17 e função de 78 em 1 ano [6]. Algum inchaço e calor no joelho podem durar meses (opinião clínica).

Prevenção de trombose (linhas gerais)

Depois da prótese, o risco de trombose aumenta, e a prevenção é rotina: andar cedo, mexer os tornozelos e, em geral, medicação por algumas semanas, às vezes com aparelhos de compressão [11]. **Método e duração são decididos pela equipe.** Grandes estudos ainda divergem sobre a melhor opção [12][13].

Só com liberação da sua equipe. A escolha destes três é opinião clínica. Exercício depois da prótese mostrou benefício pequeno a moderado nos primeiros meses; a longo prazo, é incerto [14].

Regra prática: desconforto que acalma em 1 a 2 horas é aceitável. Dor ou inchaço que pioram no dia seguinte: reduza e avise a equipe.

Exercício 1 — Bombeamento do tornozelo

Como fazer: perna esticada, puxe a ponta do pé na sua direção e depois empurre para baixo, como num pedal. 10 a 20 vezes, a cada hora acordado.

Sensação correta: a panturrilha contraindo e soltando.

Erro comum: movimento curto e apressado. Ajuda a circulação, mas **não substitui** a prevenção de trombose.

Exercício 2 — Contração da coxa

Como fazer: deitado, perna esticada, empurre a parte de trás do joelho contra a cama. Segure 5 segundos e solte. 10 vezes, 3 vezes ao dia.

Sensação correta: a coxa firme e a patela "subindo".

Erro comum: descansar com travesseiro **embaixo do joelho**: ele se acostuma dobrado.

Exercício 3 — Deslizar o calcanhar

Como fazer: deitado, deslize o calcanhar na cama em direção ao bumbum até sentir repuxar. Segure 5 segundos e volte. 10 vezes, 3 vezes ao dia.

Sensação correta: um repuxar tolerável na frente do joelho.

Erro comum: forçar com dor forte e respiração presa, ou nem tentar por medo.

Semanas 1 e 2 — Esticar e andar

- Exercícios 1, 2 e 3, três vezes ao dia.
- Caminhadas curtas dentro de casa, com o apoio indicado, várias vezes ao dia.
- No descanso, perna esticada, sem travesseiro embaixo do joelho.

Semanas 3 e 4 — Dobrar mais e ganhar confiança

- Exercícios e fisioterapia orientada.
- Caminhadas um pouco mais longas, com o apoio que a equipe liberar.

Semanas 5 e 6 — Progredir

- Progrida **uma coisa de cada vez**: tempo de caminhada **ou** número de repetições.

Os volumes são um ponto de partida prático, não um protocolo testado. O protocolo da sua equipe prevalece.

Rastreador

	Dor média (0-10)	Caminhada total no dia (min)	Joelho estica por completo? (S/N)	Exercícios feitos (vezes/dia)	Algum sinal da Página 3? (S/N)
Semana 1					
Semana 2					
Semana 3					
Semana 4					
Semana 5					
Semana 6					

0 = sem dor · 10 = a pior dor que você imagina.

Leve esta tabela para o retorno. Ela mostra a tendência, e não só o pior dia.

1. Operar esperando o joelho de antes da artrose.

Expectativa não atendida foi o fator mais ligado à insatisfação [3]. Converse antes sobre o que a prótese faz e o que não faz (Página 5).

2. Pular o tratamento sem cirurgia.

Para muita gente, exercício e orientação adiam a prótese por anos [2]. Para outros, não bastam, e aí a cirurgia faz sentido [1].

3. Descansar com o joelho dobrado.

O travesseiro embaixo do joelho alivia na hora, mas pode deixar o joelho sem esticar por completo, o que atrapalha a caminhada (opinião clínica).

4. Parar, trocar ou "esquecer" a prevenção de trombose.

O método e a duração foram escolhidos para o seu risco [11]. Qualquer mudança passa pela equipe.

5. Achar que dor no segundo mês é sinal de fracasso.

A melhora continua até 1 ano, mais devagar depois dos 3 meses [6]. Compare você com você mesmo, usando o rastreador, e não com o vizinho.

Bônus: achar que ferida que mudou é "normal da cirurgia".

Secreção, vermelhidão que aumenta ou febre pedem contato com a equipe no mesmo dia (Página 3).

Procure avaliação se:

- A artrose **dói e limita** a sua rotina apesar de exercício, controle do peso e orientação.
- Você quer saber se **já é hora da prótese** ou se ainda vale tratar sem cirurgia.
- Você operou e a recuperação **parou de evoluir** ou piorou.
- **A qualquer momento:** apareceu algum sinal da Página 3.

Se quiser uma avaliação

Sou cirurgião de joelho e opero prótese. Justamente por isso, defendo que a decisão seja tomada **sem pressa e com você bem informado** (opinião clínica).

A consulta começa por **história e exame físico**: alinhamento, movimento, estabilidade e marcha. Radiografia em pé quando indicada. Depois, conversamos sobre as opções, os riscos e o que esperar, e a decisão é tomada junto com você.

Agendamento: agendar.drrobertorodrigues.com

Instagram: @robertorodriguesmd

Atendimento em Fortaleza (CE).

Material educativo. Não substitui consulta médica. Nenhum tratamento tem resultado garantido. Cada caso precisa de avaliação individual.

1. Skou ST, Roos EM, Laursen MB, Rathleff MS, et al. **A randomized, controlled trial of total knee replacement.** N Engl J Med. 2015;373(17):1597-1606. doi:10.1056/NEJMoa1505467. PMID: 26488691.
2. Skou ST, Roos EM, Laursen MB, Rathleff MS, et al. **Total knee replacement and non-surgical treatment of knee osteoarthritis: 2-year outcome from two parallel randomized controlled trials.** Osteoarthritis Cartilage. 2018;26(9):1170-1180. doi:10.1016/j.joca.2018.04.014. PMID: 29723634.
3. Bourne RB, Chesworth BM, Davis AM, Mahomed NN, et al. **Patient satisfaction after total knee arthroplasty: who is satisfied and who is not?** Clin Orthop Relat Res. 2010;468(1):57-63. doi:10.1007/s11999-009-1119-9. PMID: 19844772.
4. Beswick AD, Wyld V, Gooberman-Hill R, Blom A, et al. **What proportion of patients report long-term pain after total hip or knee replacement for osteoarthritis? A systematic review of prospective studies in unselected patients.** BMJ Open. 2012;2(1):e000435. doi:10.1136/bmjopen-2011-000435. PMID: 22357571.
5. Evans JT, Walker RW, Evans JP, Blom AW, et al. **How long does a knee replacement last? A systematic review and meta-analysis of case series and national registry reports with more than 15 years of follow-up.** Lancet. 2019;393(10172):655-663. doi:10.1016/S0140-6736(18)32531-5. PMID: 30782341.
6. Sayah SM, Karunaratne S, Beckenkamp PR, Horsley M, et al. **Clinical course of pain and function following total knee arthroplasty: a systematic review and meta-regression.** J Arthroplasty. 2021;36(12):3993-4002.e37. doi:10.1016/j.arth.2021.06.019. PMID: 34275710.
7. Møller AM, Villebro N, Pedersen T, Tønnesen H. **Effect of preoperative smoking intervention on postoperative complications: a randomised clinical trial.** Lancet. 2002;359(9301):114-117. doi:10.1016/S0140-6736(02)07369-5. PMID: 11809253.
8. Tarabichi M, Shohat N, Kheir MM, Adelani M, et al. **Determining the threshold for HbA1c as a predictor for adverse outcomes after total joint arthroplasty: a multicenter, retrospective study.** J Arthroplasty. 2017;32(9S):S263-S267.e1. doi:10.1016/j.arth.2017.04.065. PMID: 28662955.
9. Palmer RC, Telang SS, Ball JR, Wier J, et al. **The limited utility of hemoglobin A1c as a predictor for periprosthetic joint infection following total joint arthroplasty: a continuous variable analysis.** J Arthroplasty. 2025;40(7):1836-1844.e5. doi:10.1016/j.arth.2025.01.004. PMID: 39814114.
10. Punnoose A, Claydon-Mueller LS, Weiss O, Zhang J, et al. **Prehabilitation for patients undergoing orthopedic surgery: a systematic review and meta-analysis.** JAMA Netw Open. 2023;6(4):e238050. doi:10.1001/jamanetworkopen.2023.8050. PMID: 37052919.
11. Falck-Ytter Y, Francis CW, Johanson NA, Curley C, et al. **Prevention of VTE in orthopedic surgery patients: Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines.** Chest. 2012;141(2 Suppl):e278S-e325S. doi:10.1378/chest.11-2404. PMID: 22315265.
12. Sidhu VS, Kelly TL, Pratt N, et al; CRISTAL Study Group. **Effect of aspirin vs enoxaparin on symptomatic venous thromboembolism in patients undergoing hip or knee arthroplasty: the CRISTAL randomized trial.** JAMA. 2022;328(8):719-727. doi:10.1001/jama.2022.13416. PMID: 35997730.
13. Anderson DR, Dunbar M, Murnaghan J, et al. **Aspirin or rivaroxaban for VTE prophylaxis after hip or knee arthroplasty.** N Engl J Med. 2018;378(8):699-707. doi:10.1056/NEJMoa1712746. PMID: 29466159.
14. Artz N, Elvers KT, Lowe CM, Sackley C, et al. **Effectiveness of physiotherapy exercise following total knee replacement: systematic review and meta-analysis.** BMC Musculoskelet Disord. 2015;16:15. doi:10.1186/s12891-015-0469-6. PMID: 25886975.
15. Kurtz SM, Ong KL, Lau E, Bozic KJ. **Prosthetic joint infection risk after TKA in the Medicare population.** Clin Orthop Relat Res. 2010;468(1):52-56. doi:10.1007/s11999-009-1013-5. PMID: 19669386.

Material educativo. Não substitui consulta médica.

Dr. Roberto Rodrigues · CRM-CE 10806 · RQE 12256 · TEOT 17765

